

TEMA 3.23 • OBSTETRICIA

Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal

SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM

Casos de Clasificación

TABLA 3.23.1: CASO VS EDAD					
CASO	EDAD	EG	PROTEINURIA	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
1	34 a	13 sem	Negativa	HTA crónica	Controlar con proteinuria; cambiar AHT a alfametildopa
2	44 a	17 sem	1 g/día	HTA crónica + nefropatía	Controlar proteinuria — si aumenta → sobreagregación PE
3	22 a	32 sem	1 g/día	Preeclampsia	Exámenes de severidad; evaluar interrupción
4	44 a	33 sem	Negativa	HTA gestacional	Controlar — descartar que evolucione a PE
5	28 a	Gemelar 18 sem	1 g/día	Preeclampsia (excepción: gemelar)	Exámenes de severidad; expectante si feto muy prematuro
6	—	12 sem (base), 32 sem (sube)	0,5→2 g/día	HTA crónica + nefropatía → PE sobreagregada	Dejar aspirina desde diagnóstico; detectar el momento de sobreagregación

Conducta ante Preeclampsia (resumen)

TABLA 3.23.2: SEVERIDAD VS ACCIÓN	
SEVERIDAD	ACCIÓN
No severa	Control semanal (exámenes + Doppler + RBNS)
Severa	Interrupción inmediata (o expectante hasta 34 sem si feto muy prematuro y condición estable)
< 37 sem	Corticoides antenatales antes de interrumpir

Conducta ante PE con feto muy prematuro y PE severa

- Única excepción a "interrumpir de inmediato": feto muy prematuro (< 34 sem) + madre estable + criterio de severidad leve (ej. leve disfunción renal)
- Objetivo: ganar días para maduración con corticoides, interrumpir a las 34 semanas
- Si la condición materna empeora → interrumpir de inmediato sin importar EG

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La preeclampsia severa en embarazo gemelar de 18 semanas (feto inviable) → puede indicarse interrupción si amenaza la vida materna (ley de interrupción en Chile por causal de riesgo vital).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal: Vitamina K IM en el muslo → prevención de coagulopatía del RN - Vacuna BCG (d... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Atención Inmediata al Nacer
- Secuencia de atención
- Score APGAR
- Asfixia Neonatal
- Definición y causa
- Criterios diagnósticos (todos deben estar presentes)
- Manejo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO Y ASFIXIA NEONATAL)**PREGUNTA 1**

En relación a Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal: Vitamina K IM en el muslo → prevención de coagulopatía del RN - Vacuna BCG (d... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Atención Inmediata del Recién Nacido y Asfixia Neonatal. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO Y ASFIXIA NEONATAL

1. APGAR — evaluación inicial del estado del RN (dirige la reanimación) 2. Secado — prevenir hipotermia; limpiar sangre, meconio, líquido amniótico 3. Apego — si no hay depresión respiratoria → poner al RN en el pecho materno 4. Medidas profilácticas: 5. Antropometría: peso promedio 3,5 kg, talla 50 cm, perímetro craneano 35 cm (a las 40 sem) 6. Examen físico completo — buscar malformaciones, revisar caderas, ano, reflejos, etc. 7. Screening metabólico a las 48 horas de vida: ::::note El APGAR por sí solo no hace el diagnóstico de asfixia — es uno de los criterios diagnósticos. :::: 1. APGAR 0–3 a los 5 minutos 2. pH de sangre de cordón umbilical < 7,0 3. Encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI): compromiso de conciencia, hipotonía, convulsiones 4. Afectación sistémica: IRA (oliguria, hematuria), trombocitopenia, enterocolitis necrotizante, etc.